Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ponta Porã
3ª Vara Cível

Autos 0802037-70.2018.8.12.0019
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Norma Estela Veiga de Oliveira
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Ponta Porã

Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Norma Estela Veiga de Oliveira em face do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Ponta Porã, partes já qualificados nos autos, pretendendo o fornecimento do fármaco Rituximabe 500mg, na quantidade indicada e por período suficiente ao seu tratamento.

Alega que é portadora de Púrpura Trombocitopênica Idiopática, com manifestação de Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID 10: D 69.9 e 32.8), e em virtude da patologia apresentada e dos sintomas decorrentes, lhe foi prescrita utilização do medicamento Rituximabe 500mg, a fim de evitar a extrema redução dos níveis de hemácias (pancitopenia), com risco de outras hemorragias que podem levar a paciente a óbito. Informou que já foi submetida a outros tratamentos fornecidos pelo SUS, porém, apresentou resistência a tais tratamentos.

Relatou que o Município requerido lhe negou o fornecimento do medicamento, aduzindo que o fármaco não esta na lista de medicamentos excepcionais disponibilizados dentre os Componentes de Assistência Farmacêutica Especializada. Ponderou que diante da urgência na utilização do fármaco e por não possuir condições financeiras para a sua aquisição na rede privada, socorreu-se ao Poder Judiciário para obtenção do medicamento necessário à manutenção da sua saúde. Juntou documentos (fls. 09/41).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 29/04/2019 às 18:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802037-70.2018.8.12.0019 e código zzKpSY46.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ponta Porã
3ª Vara Cível

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico, no entanto, antes de apresentado o parecer técnico, dada a urgência do caso, manifestada na inicial, foi proferida a decisão liminar de fls. 42/46 que concedeu a tutela de urgência antecipada, determinando-se aos requeridos o fornecimento à autora do medicamento Rituximabe no prazo de 15 (quinze) dias.

O NAT apresentou parecer desfavorável às fls. 52/57.

O Estado de Mato Grosso do Sul interpôs de Agravo de Instrumento em face da r. Decisão, ao qual foi dado integral provimento, conforme acórdão de fls. 135/142.

O Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação (fls. 67/79), alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, por ser o tratamento da autora de responsabilidade do Município de Ponta Porã. No mérito, aduziu que o medicamento pleiteado, apesar de estar padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, não é oferecido para o tratamento da Púrpura Trombocitopênica, e não consta no rol de medicamentos da Portaria GM/MS nº 2.982 de 26/11/2009. Alegou, ainda, que não há omissão do Estado em fornecer tratamento para a doença que acomete a autora, mas que o medicamento Rituximabe não pode ser considerado como alternativa terapêutica fora dos ensaios clínicos. Ao final, requereu a improcedência do pedido e, subsidiariamente, que não seja aplicada a pena de multa pecuniária, aduzindo que não é cabível na espécie, ou seja ela fixada em valores módicos e com termo final de sua incidência.

O Município de Ponta Porã ofertou contestação (fls. 86/94), alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, por conter pedido genérico em que pretende a autora o fornecimento de uma consulta médica e o que mais se fizer necessário ao integral tratamento da doença, e a sua ilegitimidade passiva, afirmando que não é sua atribuição o fornecimento de medicamento de alto custo e não incluído na lista do Componente Básico da Assistência, conforme Portaria n. 2.981 de 26/11/2009, do Ministério da Saúde. No mérito, asseverou a impossibilidade de prover

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 29/04/2019 às 18:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802037-70.2018.8.12.0019 e código zzKpSY46.

medicamento específico quando existente tratamentos fornecidos pelo SUS. Postulou pela revogação da tutela antecipada, e, ao final, pela total improcedência do pedido.

As contestações foram impugnadas (fls. 98/110).

As partes foram intimadas para especificação de provas, oportunidade em que a autora informou o descumprimento da decisão liminar pelos requeridos, postulando pela intimação desses para o imediato cumprimento da tutela antecipada, e, em caso de inércia dos demandados, postulou pela sequestro de valores na importância de R$ 177.484,08 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), necessária à aquisição do medicamento para tratamento pelo período de 03 meses (fls. 112/114). Juntou 03 (três) orçamentos (fls. 117/119)

Os requeridos informaram desinteresse na produção de outras provas, além das já existentes nos autos (fls. 124 e 125).

Sobreveio informação quanto ao provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado (fls. 184/223), que revogou a decisão que concedeu a tutela antecipada.

A parte autora manifestou-se no feito às fls. 144/145, juntando aos autos receituários e laudos médicos atualizados, e fotografias da autora (fls. 146/166), esclarecendo que já foram utilizados todos os medicamentos oferecidos pelo SUS para o tratamento da doença, os quais foram ineficazes.

Sobre a manifestação e novos documentos colacionados pela parte autora, manifestaram-se os requeridos (fls. 174/175 e 183), reiterando o pedido pela improcedência da ação.

A autora requereu às fls. 179/180 a produção de prova pericial médica.

Diante da nova documentação apresentada pela autora, foram os autos encaminhados ao NAT para novo parecer (fl. 224), porém, o núcleo técnico ratificou seu parecer emitido anteriormente nos autos (fl. 225).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 29/04/2019 às 18:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802037-70.2018.8.12.0019 e código zzKpSY46.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ponta Porã
3ª Vara Cível

Vieram os autos em conclusão.

É o relatório. Decido.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Norma Estela Veiga de Oliveira em face do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Ponta Porã,

No tocante ao pedido pela produção de prova pericial, formulado pela Defensoria Pública Estadual (fls. 179/180), em análise aos autos, denota-se que a prescindibilidade da prova técnica requerida, pois que suficiente ao conhecimento do mérito a prova documental até então produzida no feito.

Conforme já decidido recentemente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, em casos como o presente, os documentos juntados ao processo "(...) são suficientes para formar o convencimento nesse tipo de ação. A prova pericial demandaria mais tempo e gastos desnecessários, podendo haver agravamento da situação do autor. Cerceamento de defesa afastado. (TJMS; AC 0800249-57.2018.8.12.0007; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 15/03/2019; Pág. 82).

Destarte, indefiro a produção de prova pericial requerida pela parte autora, e, verificando desnecessária maior dilação probatória acerca do caso, passo ao julgamento antecipado da lide.

A autora pretende o fornecimento do medicamento Rituximabe 500mg, para o tratamento da doença de Púrpura Trombocitopênica Idiopática, com manifestação de Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID 10: D 69.9 e 32.8). Informou que já fez uso de todos os outros fármacos disponíveis no SUS que não foram eficazes no tratamento, e que de acordo com os laudos médicos o não tratamento com medicamento prescrito importa no risco de sangramento eminente (hemorragias), dada a extrema redução dos níveis de hemácias (pancitopenia), que podem levar a requerente a óbito. Relata que a medicação é de alto custo e devido sua condição

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 29/04/2019 às 18:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802037-70.2018.8.12.0019 e código zzKpSY46.

econômica não pode adquiri-la, necessitando que o poder público a forneça.

De início, é de ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos requeridos, que alegam não ser de sua atribuição a concessão do medicamento ora pleiteado.

A divisão das atribuição da União, Estado e Município para o fornecimento de medicamentos não retira de cada ente sua legitimidade processual e responsabilidade de cumprir com os ditames da Constituição Federal, que protegem a todos os cidadãos brasileiros que precisam de medicamentos e não possuem condições financeiras para adquiri-los.

Em que pese as argumentações dos requeridos, é de se ressalvar que o dever dos entes Federados em fornecerem medicamentos e tratamentos de saúde tem sua matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de regulamentação na legislação infraconstitucional.

A Constituição Federal, em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um sistema único (art. 198) do qual fazem parte a União, os Estados e os Municípios.

Desse modo, estabelece-se um regime de responsabilidade solidária entre a União, os Estados e os Municípios na gestão da saúde como um todo.

Logo, é de se verificar que o direito à saúde se sobrepõe às políticas públicas relativas ao Sistema Único de Saúde – SUS, de forma que estando a pessoa carente necessitada do tratamento médico, este deve ser fornecido pelos entes públicos.

Nessa linha, embora assista razão aos requeridos em afirmar que a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 29/04/2019 às 18:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802037-70.2018.8.12.0019 e código zzKpSY46.

administração de suas atividades, bem como as relacionadas ao Sistema Único de Saúde- SUS, devem ser pautadas pela isonomia, universalidade e integralidade, bem como pelo princípio da reserva do possível, tais argumentos não podem servir de escusa para o não cumprimento das obrigações constitucionais de saúde pública. Ora, o fato de a Constituição Federal dispor que o direito à saúde será garantido mediante políticas sociais e econômicas (art. 196) não significa a permissão para criação de normas que venham a excluir responsabilidades na promoção, proteção e recuperação da saúde daqueles que necessitem.

A Lei nº 8.080/90, ao regular o Sistema Único de Saúde - SUS e dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como organização o funcionamento dos serviços a ela correspondentes, estabelece no art. 6º que "estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: [...] d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

Assim, é dever do Estado prestar assistência médica e hospitalar aos cidadãos, sendo, no caso em tela, ambos os requeridos responsáveis pelo fornecimento do medicamento indicado para o tratamento da autora, uma vez que restou comprovado nos autos a enfermidade que lhe acomete, sua hipossuficiência, bem como que vem sendo submetido a tratamento pela rede pública de saúde, atendendo aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e, ainda assim, necessita do fornecimento do medicamento indicado de forma contínua, razão pela qual recorreu ao Judiciário para postular o fornecimento do tratamento prescrito.

Cabe ressaltar, no que se refere aos limites orçamentários aos quais está vinculada a parte requerida, que o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, que não é o caso dos autos, pois não há indicação concreta, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.

Ademais, já restou pacificado pela jurisprudência que o Poder Judiciário detém legitimidade para determinar a concretização de políticas públicas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 29/04/2019 às 18:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802037-70.2018.8.12.0019 e código zzKpSY46.

constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, sendo que isso não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. Nessa direção o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
>
> I – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ingressar em juízo com ação civil pública em defesa de interesses individuais indisponíveis, como é o caso do direito à saúde.
>
> II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, a realização de tratamento médico por paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Portanto, o usuário dos serviços de saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação.
>
> III – Em relação aos limites orçamentários aos quais está vinculada a ora recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.
>
> IV - Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.
>
> V – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 820910 AgR/CE, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Julgamento: 26/08/2014, DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014).

Outrossim, impende ser afastada a preliminar de inépcia da inicial, alegada pelo Município requerido, pois, por certo que não se trata de pedido genérico a pretensão do fornecimento de medicamento específico (Rituximabe 500mg) para

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 29/04/2019 às 18:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802037-70.2018.8.12.0019 e código zzKpSY46.

tratamento de doença também especificada (Púrpura Trombocitopênica Idiopática -PTI CID10: D 69.3).

Por tais razões, rejeito as preliminares arguidas pelos requeridos.

Quanto ao mérito, compulsando os autos, verifica-se que os documentos trazidos pela parte autora são inequívocos ao apontar a necessidade da paciente em fazer uso da medicação, conforme indicação médica, por correr risco à sua saúde e até à vida.

No Recurso Especial n. 1.657.156/RJ - afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o qual foi julgado na data de 28/04/2018, firmou-se a seguinte tese aplicável ao caso:

> ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
> (...)
> 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
> 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7); Relator: Ministro Benedito Gonçalves Recorrente; Data do Julgamento: 25/04/2018) – Destaquei.

Todos os requisitos foram preenchidos pela requerente, pois a médica que a acompanha esclareceu e fundamentou a necessidade do uso do fármaco sob risco de agravamento da doença, bem como informou que as opções disponibilizadas pelo SUS já foram todas utilizadas. Do parecer elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico, consta que o medicamento está registrado na ANVISA e incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e possui alto custo, sendo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 29/04/2019 às 18:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802037-70.2018.8.12.0019 e código zzKpSY46.

a parte autora comprovadamente hipossuficiente (fl. 09).

Nesse aspecto, cumpre-se ressaltar que a autora não esta sendo atendida por médico particular, mas pelo SUS, o que corrobora ainda mais sua condição de hipossuficiente.

Em que pese o parecer desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, e o entendimento exposto no Acórdão proferido pelo TJMS no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado em face da decisão que concedeu a antecipação da tutela à autora, de que "o questionário apresentado, embora tenha sido elaborado por profissional habilitado para este fim, não oferece a segurança necessária para afirmar que os medicamentos fornecidos pelo SUS (prednisona, dexametasona, ciclofosfamida, danazol e vincristina), não produzem os mesmos efeitos daqueles indicados pelo médico particular que atende a agravada", tenho que, diversamente do alegado, os laudos e questionários médicos acostados aos autos são claros e uníssonos em afirmar que a autora já fez uso de todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS, inclusive, com expressa menção àqueles medicamentos apontados pelo NAT e mencionados no referido acórdão (vide relatório médico atualizado de fls. 181/182).

Além disso, o próprio NAT, em seu parecer (fls. 52/57), relata que o medicamento Rituximabe vem sendo utilizado no tratamento da Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI) quando o tratamento disponibilizado (com corticoides e outros) não se mostra eficaz, como no caso presente. Ainda, o próprio NAT opina para que seja o medicamento considerado no tratamento da referida doença refratária:

> "O rituximabe vem sendo usado em pacientes com PTI refratária aos tratamentos de primeira linha, ou seja, corticoides e esplenectomia. (...)Na ausência de um estudo prospectivo randomizado, é difícil ter certeza, mas os dados atualmente disponíveis sugerem que o rituximabe pode aumentar a atividade de ADAMTS13, diminuir o tempo para a resposta da contagem de plaquetas, reduzir a duração da plasmaférese (PEX), e potencialmente ser

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 29/04/2019 às 18:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802037-70.2018.8.12.0019 e código zzKpSY46.

> eficaz na prevenção de recaídas. Em nossa opinião, agora é razoável considerar o tratamento de indivíduos que têm TTP adquirido refratário com rituximabe, se eles não conseguiram responder a PEX e esteroides."(fl. 56). – destaquei.

Feitas tais ponderações, esclareça-se, ainda, que no presente caso estão atendidas as recomendações contidas nos Enunciados de Direito da Saúde do CNJ, uma vez que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA (Enunciado n. 06, III Jornada de Direito da Saúde), não se trata de produto ou procedimento experimental (off label) (Enunciado n. 50, III Jornada de Direito da Saúde), bem como restou demonstrada a inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde -SUS (Enunciado n. 12, III Jornada de Direito da Saúde).

A médica especialista deixou bastante clara a necessidade do medicamento, apontando que a paciente não obteve bom resultado com o uso dos medicamentos/tratamentos oferecidos pelo SUS e que a ausência do medicamento ora prescrito pode resultar em complicações do caso e piora do quadro, inclusive podendo levar a paciente a óbito.

A profissional habilitada, que acompanha o tratamento e evolução da doença, é quem tem melhores condições de averiguar as reais necessidades do paciente, tornando-se impertinente a discussão acerca da observância ou não aos parâmetros fixados nas políticas existentes, uma vez que demonstrada a necessidade da autora em receber a medicação pleiteada.

Demonstrada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento e a incapacidade financeira da parte de custea-lo, entendo que a obrigação de fornecer o fármaco, de modo algum fere a razoabilidade que deve pautar o dever do Estado lato sensu de prestar assistência à saúde.

Uma vez comprovada a necessidade de tratamento com o medicamento de alto custo, o qual possui registro na ANVISA e consta na lista de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 29/04/2019 às 18:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802037-70.2018.8.12.0019 e código zzKpSY46.

medicamentos fornecidos pelo SUS (RENAME), bem como a hipossuficiência da autora (fl. 09), inadmissível a escusa do Poder Público em lhe fornecer o tratamento necessário.

Desse modo, os pedidos constantes na presente ação devem ser julgados procedentes.

Já no tocante ao pedido do Estado requerido quanto à revogação/redução da multa cominatória, tenho que não deve prosperar.

Ressalta-se que tal medida visa, exatamente, compelir o réu ao cumprimento da determinação imposta, e no presente caso, ao fornecimento da medicação prescrita. Outrossim, é assente a possibilidade de aplicação, nestes casos, de multa cominatória em face da Fazenda Pública:

> APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - REEXAME NECESSÁRIO ARGUIDO DE OFÍCIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RESPONSABILIDADE PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (ART. 196, CF) - DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE DE TODOS - POSSIBILIDADE DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - VALOR DAS ASTREINTES - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 421, DO STJ - RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS - APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PROVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Hipótese em que se discute o dever do Estado de fornecer medicamento. 2. A dispensa de Reexame Necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta (60) salários mínimos, não se aplica às sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ). 3. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O pólo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente." (RE 855178RG/PE, Rel. Min. Luix Fux, julgado pelo rito do art. 543-B, do Código de Processo Civil, em 05/03/2015). 4. É cediço que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, da Constituição Federal). 5. É cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. 6. As astreintes têm por finalidade constranger o devedor a cumprir o estipulado na decisão judicial, motivo pelo qual não poderá ter valor irrisório, devendo ser fixada em quantia suficiente para se atingir tal finalidade, conforme ocorreu in casu. 7. Com relação ao Município, não há confusão entre a figura do devedor e a do credor de honorários (Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira; Comarca: Chapadão do Sul; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 06/09/2016; Data de registro: 14/09/2016)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 29/04/2019 às 18:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802037-70.2018.8.12.0019 e código zzKpSY46.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ponta Porã
3ª Vara Cível

Com relação a importância da multa, Nelson Nery Junior e Rosa Andrade Nery ensinam que: "O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz". (in Código de Processo Civil, Comentado e Legislação Extravagante, editora Revista dos Tribunais, 7ª edição, pág. 782).

Desta forma, o afastamento da multa ou mesmo a redução do seu valor poderia servir de incentivo para que a decisão judicial fosse descumprida, motivo pelo qual não merece acolhimento.

ISSO POSTO, julgo procedente o pedido inicial para o fim de condenar os requeridos na obrigação de fazer para o fim específico de fornecer à autora Norma Estela Veiga de Oliveira o medicamento Rituximabe 500mg, na quantidade e forma de administração especificados na prescrição médica, enquanto perdurar seu tratamento.

Intime-se os requeridos para cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sem imposição de custas, ante a isenção legal.

Condeno o Município de Ponta Porã ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado, a serem depositados na conta do Fundo Especial para Desenvolvimento das Atividades do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul – FUNADEP, no valor de R$ 300,00, com base no § 8º do art. 85 do CPC, atendendo-se ao zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, a natureza e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 29/04/2019 às 18:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802037-70.2018.8.12.0019 e código zzKpSY46.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ponta Porã
3ª Vara Cível

importância da causa, ao trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para o serviço e o valor da causa.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso do Sul a arcar com os honorários advocatícios, uma vez que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública, em atenção à Súmula 421 do STJ.

Decorrido o prazo para recurso voluntário das partes, remetam-se os autos à superior instância para reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se.

Ponta Porã, 29 de abril de 2019.

Tatiana Decarli
Juíza de Direito
(assina por certificação digital)

Endereço: Rua: Baltazar Saldanha, nº 1.817, Fax: (067) 3431-1560, Jardim Ipanema - CEP 79904-202, Fone: (67) 3431-2441, Ponta Porã-MS - E-mail: ppr-3vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 29/04/2019 às 18:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802037-70.2018.8.12.0019 e código zzKpSY46.